



YAYASAN KENDEDES MALANG
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDEDES MALANG

SK Mendiknas RI No. 47/D/O/2009

Program Studi : 1. D-III Kebidanan 2. D-III Keperawatan 3. S-1 Keperawatan

4. Profesi Ners (SK Mendikbud RI No. 224/E/O/2014)

5. Kebidanan Program Sarjana 6. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi
(SK Mendikbud RI No. 887/M/2020)

Jl. R. Panji Suroso No. 6 Malang

Telp. (0341) 488762, 480497, Fax. (0341) 488763

Nomor : 181.A.2.1/AKD/X/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo Pasurusn

Di -
Tempat

Menunjuk :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 047/D/O/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan STIKes Kendedes Malang;
2. Kalender Akademik Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Kendedes Malang TA. 2025/2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Bapak/ Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasurusn, untuk memberikan rekomendasi ijin penelitian kepada mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Kendedes Malang dibawah ini :

Nama : Intania Cahya Andini
NIM : 2401160877
Judul Skripsi : Pengaruh Teknik Distraksi Visual dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi pada Anak Usia Prasekolah di RS. Prima Husada Sukorejo

Pelaksanaan pada Bulan Oktober 2025.

Demikian permohonan kami, atas kebijaksanaan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, M.Kep
NIDN. 0711078807

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Ka. LPPM STIKes Kendedes Malang
2. Ka. BAAK STIKes Kendedes Malang

**PENGARUH TEKNIK DISTRAKSI VISUAL DAN TERAPI
BERMAIN MEWARNAI TERHADAP KECEMASAN
HOSPITALISASI PADA ANAK USIA
PRASEKOLAH DI RS PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Tinggi Sarjana Keperawatan**



DISUSUN OLEH :

**INTANIA CAHYA ANDINI
2401160877**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENEDES MALANG
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN**

2025

**PENGARUH TEKNIK DISTRAKSI VISUAL DAN TERAPI
BERMAIN MEWARNAI TERHADAP KECEMASAN
HOSPITALISASI PADA ANAK USIA
PRASEKOLAH DI RS PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Tinggi Sarjana Keperawatan**



DISUSUN OLEH :

**INTANIA CAHYA ANDINI
2401160877**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENEDES MALANG
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Skripsi STIKes Kendedes Malang dengan judul “Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia PraSekolah Di RS Prima Husada Sukorejo” telah disetujui oleh pembimbing penyusunan proposal Skripsi Program Studi S1 Keperawatan pada

Hari,tanggal.....

Malang,

Mahasiswa,

Intania Cahya Andini
2401160877

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ns.Luluk Nur Aini,M.Kep
NIDN. 0705027801

Desy Rinawaty,M.Tr.Kep.
NIDN. 0703129701

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo” telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi STIKes Kendedes Malang Prodi S1 Keperawatan.

Telah diuji pada
Hari :
Tanggal :
Dan disahkan oleh

Ns. Putu Sintya Arlinda A,M.Kep
NIDN. 0711078807
Penguji I

(.....) (.....)
Tanda Tangan Tanggal

Ns.Luluk Nur Aini,M.Kep
NIDN. 0705027801
Pembimbing I

(.....) (.....)
Tanda Tangan Tanggal

Desy Rinawaty,M.Tr.Kep
NIDN. 0703129701
Pembimbing II

(.....) (.....)
Tanda Tangan Tanggal

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Keperawatan
STIKes Kendedes Malang

Ns. Putu Sintya Alinda Arsa,M.Kep
NIDN. 0711078807

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penelitian mampu menyelesaikan Proposal yang berjudul “Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo”. Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Proposal ini masih banyak kekurangan namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat menyelesaikan, baik melalui konsultasi dengan pembimbing dan membaca berbagai jurnal/literatur. Oleh karena itu ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. dr. Muljo Hadi Sungkono, Sp. OG (K), selaku Pembina Yayasan Kendedes Malang.
2. drg. Suharwati, selaku Ketua Yayasan Kendedes Malang.
3. dr. Endah Puspitorini, MScIH, DTMPH, selaku PLH STIKes Kendedes Malang.
4. Dr. Jenny J.S. Sondakh, S.Si. T, .Clin.Mid, selaku Ketua STIKes Kendedes Malang.
5. Penguji adalah Ns. Putu Sintya Arlinda A., M.Kep saya masukan yang telah diberikan.
6. Pembimbing 1 adalah Ns. Luluk Nur Aini, M.Kep yang sudah membimbing saya, saya ucapkan terimakasih banyak.
7. Pembimbing adalah Desy Rinawaty, M. Tr.Kep yang sudah membimbing saya, saya ucapkan terimakasih banyak.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memancurahkan cinta kasih sayangnya dan do'a-do'a dalam setiap langkahku.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat masih terbatasnya ilmu dan pengalaman, oleh karena itu peneliti tidak

menutup diri bila ada kritik dan saran yang bersifat membangun agar penyusunan proposal ini lebih sempurna di mas yang akan datang. Semoga penyusun proposol ini dapat bermanfaat dan berguna bagi profesi dan para pembacanya.

Malang,.....2025

Intania Cahya Andini
2401160877

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Tabel Definisi Operasional.....	23
Tabel 5.1 Frekuensi Jenis Kelamin.....	33
Tabel 5.2 Frekuensi Usia.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar kerangka konsep

|

RI

KEMENKES

DAFTAR SINGKATAN

: Rumah Indonesia

: Kementerian Kesehat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak prasekolah merupakan masa kanak-kanak awal yaitu berada pada usia 3-6 tahun, masa yang menyenangkan dan dipengaruhi dengan segala macam hal yang baru (Wardani dkk., 2023). Hospitalisasi merupakan suatu proses yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani terapi dan perawatan yang sampai pemulangan kembali ke rumah (Sudirman dkk., 2023). Anak yang dirawat di rumah sakit biasanya mengalami cemas. Kecemasan dapat mempengaruhi anak-anak pada waktu yang berbeda, misalnya saja menjelang saat mereka berpisah dengan orang tuanya, atau saat mereka menghadapi perubahan besar dalam hidupnya (Siahaan, 2022). Kecemasan yang dialami oleh anak yang dirawat dapat dihibur dengan beberapa permainan agar anak-anak betah di rumah sakit dan tenang. Teknik distraksi visual adalah kombinasi antara pendengaran dan penglihatan yang dilakukan dengan cara menonton film kartun. Terapi bermain mewarnai adalah salah satu kegiatan yang sesuai dengan prinsip rumah sakit dimana secara psikologis, kegiatan ini dapat membantu anak dalam mengekspresikan perasaan cemas, takut, sedih, tertekan dan emosi (Lestari & Suminar, 2024).

Berdasarkan prevalensi data WHO secara global anak yang mengalami stress dan kecemasan akibat hospitalisasi sebesar 3%-10% (Siahaan, 2022). Di Indonesia anak yang mengalami kecemasan saat hospitalisasi sebesar 15,26% (Leni, 2020). Data kecemasan pada anak saat hospitalisasi juga didukung oleh data dari provinsi Jawa Timur bahwa anak pernah mengalami sakit dan merasa cemas saat hospitalisasi sebesar 85% (Wardani dkk., 2023). Data prevalensi dari

ruangan anak di rumah sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Agustus 2025 pasien prasekolah sebanyak 60 pasien (Rekam Medis RS Prima Husada Sukorejo, 2025).

Dampak hospitalisasi pada anak prasekolah saat dirawat di rumah sakit dapat di tandai dengan perilaku anak diantaranya adalah penolakan yaitu anak menghindari dari situasi yang membuatnya tertekan dan bersikap tidak kooperatif terhadap petugas. Lingkungan perawatan rumah sakit yang dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan pada anak. Kecemasan hospitalisasi pada anak dapat membuat anak menjadi susah makan, tidak tenang, takut, gelisah, cemas dan tidak mau bekerjasama dalam tindakan medikasi sehingga mengganggu proses penyembuhan anak (Wardani dkk., 2023). Anak usia prasekolah memandang hospitalisasi sebagai sebuah pengalaman yang menakutkan. Ketika anak menjalani perawatan di rumah sakit, biasanya ia akan dilarang untuk banyak bergerak dan harus banyak beristirahat. Hal tersebut tentunya akan mengecewakan anak sehingga dapat meningkatkan kecemasan pada anak (Machillah & Basuki, 2021).

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan pada anak yaitu teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai. Teknik distraksi visual merupakan metode rangsangan penglihatan (visual) untuk mengalihkan fokus pasien dari situasi yang menimbulkan rasa tidak nyaman, cemas, atau takut (Triana, 2025). Terapi bermain mewarnai adalah salah satu permainan yang memberikan kesempatan anak untuk bebas berekspresi dan sangat terapeutik (sebagai permainan penyembuh) (Machillah & Basuki, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dkk (2023) bahwa penelitian ini dilakukan oleh bulan Agustus-Oktober 2022 peneliti mendapatkan data untuk anak usia prasekolah yaitu pada usia 3-6 tahun sebanyak 25 pasien. Hasil penelitian dilakukan dengan uji T-test yang menunjukkan Adanya pengaruh Terapi Mewarnai Gambar Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Anak Prasekolah Selama Hospitalisasi di Ruang Jasmine RS Yadika Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2022. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah dkk (2024) bahwa dilakukan penelitian bulan Agustus 2024 dengan sampel 50 responden yang dirawat di rumah sakit An-Nisa. Hasil dari penelitian ini terapi bermain mewarnai terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah di RS An-Nisa. Terapi bermain mewarnai efektif dalam menurunkan kecemasan pada anak saat hospitalisasi.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lestari & Suminar (2024) bahwa penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2022. Hasil penelitian dari 45 responden sebelum dilakukan teknik distraksi audiovisual sebagian besar mengalami kecemasan berat sebanyak 25 anak (56%), cemas sedang sebanyak 15 anak (33%), tidak ada yang mengalami cemas ringan dan tidak cemas. Sesudah dilakukan teknik distraksi audiovisual sebagian besar mengalami cemas ringan sejumlah 30 anak (67%) dan cemas sedang sejumlah 5 anak (11%). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayah dkk (2025) bahwa penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2024 yang memiliki hasil penelitian pengaruh bercerita dengan media boneka jari terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah selama hospitalisasi di RSUD Koja.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi sebelum dan sesudah dilakukan teknik distraksi visual terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.
2. Mengidentifikasi sebelum dan sesudah dilakukan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.
3. Menganalisis pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan sumber informasi bagi kemajuan ilmu keperawatan tentang pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Responden

Untuk menimbulkan rasa tidak tegang pada anak dan mengurangi rasa cemas pada anak.

2. Bagi Tempat

Peneliti memberikan masukan bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dengan melaksanakan program teknik distraksi dan terapi bermain mewarnai pada anak usia prasekolah yang mengalami kecemasan hospitalisasi dan untuk menjadikan rumah sakit ramah anak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisa pengaruh pengaruh distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi oleh peneliti selanjutnya dalam memilih metode pembelajaran untuk peningkatan pemahaman.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini yaitu 1.) Konsep Prasekolah 2.) Konsep Hospitalisasi 3.) Konsep Kecemasan 4.) Konsep Distraksi Visual 5.) Konsep Bermain Mewarnai 6.) Penelitian Terkait.

2.1 Konsep Prasekolah

2.1.1 Pengertian Prasekolah

Anak usia prasekolah merupakan anak usia antara 4-6 tahun. Anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini yang ditandai dengan perkembangan jasmani, meningkatnya keterampilan dan proses berpikir (Khalimi, 2023). Prasekolah adalah periode perkembangan yang berlangsung dari akhir masa bayi usia 5 atau 6 tahun (Kurnisar dkk., 2024).

2.1.2 Tugas Perkembangan Usia Prasekolah

Tugas perkembangan usia prasekolah menurut Kurnisar dkk (2024) antara lain:

1. Belajar keterampilan fisik yang diperlakukan untuk bermain.
2. Mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri, seperti pemahaman tentang nilai diri dan potensi diri.
3. Menjalin hubungan dengan teman sebaya berdasarkan norma-norma moral yang diterima di masyarakat.
4. Mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung.
5. Mengembangkan peran social sesuai jenis kelamin.
6. Memperluas pemahaman tentang ide-ide yang diperlakukan untuk di kehidupan sehari-hari.

7. Membentuk sikap objektif, baik yang positif maupun negative terhadap kelompok dan masyarakat.
8. Belajar meraih kebebasan pribadi untuk menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab.
9. Mempelajari toilet training, yaitu cara buang air kecil dan buang air besar yang dapat diterima secara social.
10. Belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, keluarga, dan orang lain.
11. Mengembangkan pengetahuan agama sesuai dengan tingkat usianya.

2.1.3 Jenis Perkembangan Anak Usia Prasekolah

Jenis perkembangan anak usia prasekolah menurut Khalimi (2023) antara lain:

1. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik pada anak usia prasekolah meliputi berat badan yang mengalami kenaikan pertahunnya rata-rata 2 kg, setiap tubuh mengalami kematangan seperti berjalan, melompat, dan lain-lain. Selain berat badan, ada juga yang mengalami kenaikan yaitu tinggi badan rata-rata 6,75-7,5 cm meter setiap tahunnya.

2. Perkembangan Motorik

Perkembangan pada motorik ada dua yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus merupakan pengorganisasian penggunaan otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering menumbuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan. Motorik kasar merupakan gerakan fisik yang membutuhkan keseimbangan

dan koordinasi antar anggota tubuh.

3. Perkembangan Psikososial

Perkembangan psikososial pada usia anak prasekolah telah menguasai rasa otonom dan memindahkan untuk menguasai rasa inisiatif. Anak prasekolah mulai menggunakan Bahasa sederhana dan dapat bertoleransi terhadap keterlambatan dalam pemusatan dalam periode yang lama.

4. Perkembangan Moral

Anak prasekolah berada pada tahap pre konvensional pada tahap perkembangan moral yang berlangsung sampai usia 10 tahun. Pada fase ini, kesadaran timbul dan penekanannya pada kontrol eksternal. Standar moral anak berada pada orang lain dan ia mengobservasi untuk menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran.

2.1.4 Prasekolah

2.2 Konsep Hospitalisasi

2.2.1 Pengertian Hospitalisasi

Hospitalisasi adalah suatu proses karena alasan berencana maupun darurat yang mengharuskan anak dirawat atau tinggal di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang dapat menyebabkan beberapa perubahan psikis pada anak (Leni, 2020). Hospitalisasi merupakan suatu proses yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani terapi dan perawatan yang sampai pemulangan kembali ke rumah (Sudirman dkk., 2023).

2.2.2 Dampak Hospitalisasi

Hospitalisasi atau sakit dan dirawat dirumah sakit bagi anak dan keluarga akan menimbulkan stress dan tidak aman. Jumlah dan efek stress tergantung pada persepsi anak dan keluarga terhadap kerusakan penyakit dan pengobatan (Leni, 2020).

2.2.3 Faktor Mempengaruhi Reaksi Anak Prasekolah Terhadap Hospitalisasi

Faktor yang mempengaruhi reaksi anak prasekolah terhadap hospitalisasi menurut Leni (2020) antara lain:

1. Perkembangan Usia

Reaksi anak terhadap sakit berbeda-beda sesuai tingkat perkembangan anak. Pada anak usia prasekolah reaksi perpisahan adalah kecemasan karena berpisah dengan orang tua dan kelompok sosialnya. Pasien anak usia prasekolah umumnya takut pada dokter dan perawat.

2. Pengalaman Dirawat Di Rumah Sakit Sebelumnya

Apabila anak pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan dirawat dirumah sakit sebelumnya akan menyebabkan anak takut dan trauma. Sebaliknya apabila anak dirawat dirumah sakit mendapatkan perawatan yang baik dan menyenangkan anak akan lebih kooperatif pada perawat dan dokter.

3. Support Sistem yang Tersedia

Anak mencari dukungan dari orang lain untuk melepaskan tekanan akibat penyakit yang dideritanya. Anak biasanya akan meminta dukungan kepada orang tua atau saudaranya.

2.2.4 Reaksi Anak Prasekolah Terhadap Hospitalisasi

Banyak anak prasekolah melihat rumah sakit sebagai lingkungan yang asing dan menakutkan. Lama tinggal di rumah sakit serta pengalaman rawat inap sebelumnya berpengaruh terhadap tingkat kecemasan dan reaksi stres anak. Anak dengan pengalaman lebih lama atau berkali-kali cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dan reaksi stres yang lebih kuat. Kecemasan akibat hospitalisasi pada anak prasekolah biasanya muncul sebagai penolakan, menangis, kecemasan saat dipisahkan dari orang tua, menarik diri, dan perilaku menghindar. Dukungan dari orang tua dan keluarga-baik secara emosional, informasional, maupun instrumental-memainkan peran penting dalam membantu anak mengatasi stres akibat hospitalisasi (Leni, 2020).

2.3 Konsep Kecemasan

2.3.1 Pengertian Kecemasan

Kecemasan adalah perasaan yang sangat berlebihan terhadap kondisi ketakutan, kegelisahan, bencana yang akan datang, kekhawatiran atau ketakutan terhadap ancaman nyata atau yang dirasakan (Leni, 2020). Kecemasan adalah gambaran emosional seseorang yang ditandai perasaan ketakutan disertai dengan perubahan system saraf otonom (Yan, 2023).

2.3.2 Tingkat Kecemasan

Tingkat kecemasan dibagi 4 macam menurut Yan (2023) antar lain:

1. Kecemasan Ringan

Pada tingkat kecemasan ringan ini persepsi anak menjadi mulai melebar secara mendadak. Anak termotivasi belajar mengenali stimulus dan mencoba menghasilkan kreativitas terhadap lingkungan sekitar. Kecemasan ringan masih dapat dikontrol. Tanda kecemasan ringan yaitu berupa gelisah, mudah marah dan perilaku mencari perhatian.

2. Kecemasan Sedang

Kecemasan sedang berkaitan dengan koordinasi dengan lingkungan yang menurun. Anak lebih tertarik memperhatikan pada hal yang penting saat itu dan cenderung melupakan kondisi lain sebagai ancaman dalam beraktivitas. Pada tingkat ini anak mengamati perubahan perilaku banyak secara emosional sehingga perilaku anak mulai sulit dikontrol dengan baik. Kecemasan sedang yang dialami anak dapat mempengaruhi perubahan perilaku secara langsung dan bertap. Tanda kecemasan sedang yaitu suara bergetar, perubahan dalam nada suara, gemeteran, peningkatan ketegangan otot.

3. Kecemasan Berat

Pada kecemasan berat telah terjadi penyempitan pandangan terhadap perubahan lingkungan. Anak hanya tertarik dengan untuk hal-hal kecil dan menolak untuk hal lainnya bahkan berfikir dengan berat terhadap apa yang terjadi saat itu. Tanda kecemasan berat yaitu perasaan terancam, ketegangan otot berlebihan, perubahan pernafasan, perubahan gastrointestinal (mual, muntah, rasa terbakar

diulu hati, anoreksia dan diare).

4. Panik

Pada tingkat ini anak mulai menunjukkan perilaku yang tidak dapat mengendalikan diri. Kondisi panik anak terlihat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya bahkan setelah diberi pengarahan atau tuntunan. Tanda panik yaitu mudah mengamuk dan sangat marah, mengis keras, dan pikiran sangat kacau.

2.3.3 Faktor Mempengaruhi Kecemasan Anak Prasekolah

Faktor mempengaruhi kecemasan anak prasekolah menurut Leni (2020) antara lain:

1. Faktor Usia

Usia dikaitkan dengan pencapaian perkembangan kognitif anak. Anak usia prasekolah belum mampu menerima dan mempersepsikan penyakit dan pengalaman baru dengan lingkungan asing.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi tingkat stress hospitalisasi, dimana anak perempuan yang menjalani hospitalisasi memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki, walaupun ada beberapa yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan anak.

3. Pengalaman Terhadap Sakit dan Perawatan Hospitalisasi

Anak yang mempunyai pengalaman hospitalisasi sebelumnya akan memiliki kecemasan yang lebih rendah

dibandingkan dengan anak yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Respon anak menunjukkan peningkatan sensitivitas terhadap lingkungan dan mengingat dengan detail kejadian yang dialaminya dan lingkungan disekitarnya.

4. Anak Terhadap Sakit

Anak sakit dengan jumlah keluarga cukup besar mempengaruhi persepsi dan perilaku anak dalam mengatasi masalah menghadapi hospitalisasi. Dukungan keluarga sangat membantu selama hospitalisasi.

2.3.4 Respon Terhadap Anak Prasekolah

Respon terhadap kecemasan anak prasekolah menurut Leni (2020) antara lain:

1. Respon Fisiologis

Secara fisiologis respon tubuh terhadap kecemasan adalah dengan mengaktifkan system syaraf otonom (simpatis maupun para simpatis). Anak yang mengalami gangguan kecemasan akibat perpisahan akan menunjukkan sakit perut, sakit kepala, mual, muntah, gelisah, sulit berkonsentrasi, dan mudah marah.

2. Respon Psikologis

Secara psikologis respon kecemasan adalah tampak gelisah, terhadap ketegangan fisik, reaksi terkejut, bicara cepat, menarik diri dari. Secara psikologis respon kecemasan adalah tampak gelisah, terhadap ketegangan fisik, reaksi terkejut, bicara cepat, menarik diri dari.

3. Respon Kognitif

Kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan berfikir baik proses pikir maupun isi pikir, diantaranya adalah tidak mampu memperhatikan, konsentrasi menurun, mudah lupa, bingung, perasaan takut, mimpi buruk.

4. Respon Afektif

Secara afektif anak akan mengekspresikan dalam bentuk kebingungan, gelisah, tegang, gugup, khawatir, dan curiga berlebihan sebagai reaksi emosi terhadap kecemasan.

2.3.5 Alat Ukur Kecemasan

Alat ukur kecemasan menurut Yan (2023) antara lain:

1. *Zung Self Anxiety Scale*

Zung Self Rating Anxiety Scale merupakan metode pengukur tingkat kecemasan. Skala ini berfokus pada kecemasan secara umum dan koping dalam mengatasi stress. Skala ini terdiri dari 20 pertanyaan dengan 15 pertanyaan tentang peningkatan kecemasan dan pertanyaan tentang penurunan kecemasan.

2. *Homilton Anxiety Scala*

Hamilton Anxiety Scala (HAS) disebut juga dengan *Hamilton Anxiety Ratting Scale (HARS)*, pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton pada tahun 1956, untuk mengukur semua tanda kecemasan baik kecemasan psikis maupun somatic. HARS terdiri dari 14 item pertanyaan untuk mengukur tanda adanya kecemasan pada anak dan

orang dewasa.

3. *Preschool Anxiety Scale*

Prescholl Anxiety Scale merupakan kuesioner ini mencakup pertanyaan dari anak. *Spence Children's Anxiety Scale* tahun 1994 dan laporan orang tua (*Spence Children's Anxiety Scale Parent Report*) pada tahun 2000. Alat ukur ini terdiri dari 28 pertanyaan kecemasan. Skala ini dilengkapi dengan meminta orang tua untuk mengikuti petunjuk pada lembar instrument. Jumlah skor maksimal pada skala kecemasan *Preschool Anxiety Scale* adalah 112. Dua puluh delapan item kecemasan tersebut memberikan ukuran keseluruhan kecemasan, selain nilai pada 6 sub skala masing-masing menekankan aspek tertentu dari kecemasan anak, yaitu kecemasan umum, sosial, gangguan obsesif kompulsif, ketakutan cedera fisik dan, kecemasan perpisahan.

4. *Children Manifest Anxiety Scale (CMAS)*

Pengukuran kecemasan dengan CMAS berisi 50 pertanyaan, dimana responden menjawab keadaan “ya” atau “tidak” sesuai dengan keadaannya, dengan memberi tanda (O) pada kolom jawaban “ya” atau tanda (X) pada kolom jawaban “tidak”.

5. *Screen For Child Anxiety Related Disorders (SCARED)*

Screen For Child Anxiety Related Disorders (SCARED) merupakan instrumen untuk mengukur kecemasan pada anak yang terdiri dari 41 item, dalam instrument ini responden (orang tua/pengasuh) diminta untuk menjelaskan bagaimana perasaan anak

dalam 3 bulan terakhir. Instrument ini ditujukan pada anak usia 8 tahun hingga 18 tahun.

6. *The Pediatric Rating Scale (PARS)*

The Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) digunakan untuk menilai tingkat keparahan kecemasan pada anak-anak dan remaja, dimla usia 6 tahun sampai 17 tahun. PARS memiliki dua bagian yaitu, daftar periksa gejala dan item keparahan. Daftar periksa gejala digunakan untuk menentukan gejala-gejala pada minggu-minggu terakhir. Ketujuh item tingkat keparahan digunakan untuk menentukan tingkat keparahan gejala dan skor total PARS.

Dalam penelitian kali ini, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecemasan adalah Preschool Anxiety Scale alat ukur ini terdiri dari 28 pertanyaan kecemasan. Skala ini dilengkapi dengan meminta orang tua untuk mengikuti petunjuk pada lembar instrument Dua puluh delapan item kecemaan tersebut memberikan ukuran keseluruhan kecemasan, selain nilai pada 6 sub skala masing-masing menekankan aspek tertentu dari kecemasan anak, yaitu kecemasan umum, sosial, gangguan obsesif kompulsif, ketakutan cedera fisik dan kecemasan perpisahan. Masing-masing kelompok gejala diberi penilaian sebagai berikut:

< 28 = gejala ringan

29-56 = gejala sedang

57-84 = gejala berat

> 85 = sangat berat/panik

Jumlah pertanyaan dalam instrument ini terdiri dari 6 sub skala kecemasan dan pada item pertanyaan sebagai berikut:

1,4,8,14, dan 28 = kecemasan umum

2,5,11,15, dan 23 = kecemasan social

3,9,18,21, dan 27 = gangguan obsesif kompulsif

7,10,13,17,20,24, dan 26 = ketakutan cedera fisik

6,12,16,22, dan 25 = kecemasan perpisahan

2.4 Konsep Dasar Distraksi Visual

2.4.1 Pengertian Distraksi Visual

Distraksi visual adalah suatu cara untuk mengalihkan fokus anak terhadap rasa sakit melalui instrumen visual yang menyenangkan bagi anak (Maulidia dkk., 2023). Distraksi visual adalah pengalihan perhatian selain nyeri yang diarahkan ke dalam tindakan-tindakan visual atau pengamatan (Purnama dkk., 2024).

2.4.2 Manfaat Distraksi Visual

Distraksi visual digunakan untuk mengalihkan perhatian pasien terhadap hal-hal yang membuatnya tidak nyaman, cemas atau takut dengan cara menampilkan tayangan favorit berupa gambar-gambar bergerak dan bersuara ataupun animasi dengan harapan pasien terbawa keseruannya melalui apa yang dilihat sehingga mengabaikan rasa tidak nyaman atau rasa takut dan menunjukkan respons penerimaan yang baik (Maulidia dkk., 2023).

2.4.3 Tujuan Distraksi Visual

Distraksi visual digunakan untuk mengalihkan perhatian pasien

terhadap hal-hal yang membuatnya tidak nyaman, cemas atau takut dengan cara menampilkan tayangan favorit berupa gambar-gambar bergerak dan bersuara ataupun animasi dengan harapan pasien asik terhadap tontonannya sehingga mengabaikan rasa tidak nyaman dan menunjukkan respon penerimaan yang baik (Maulidia dkk., 2023).

2.4.4 Durasi Distraksi Visual

Dalam melakukan distraksi visual dilakukan minimal 5-10 menit. Cara pasien diminta untuk melihat pemandangan atau gambar-gambar yang indah, foto atau film sehingga dapat memberikan efek terapeutik (Maulidia dkk., 2023).

2.4.5 Langkah-Langkah Distraksi Visual

Langkah-langkah distraksi visual menurut Maulidia dkk (2023). antara lain:

1. Tahap Pra Interaksi
 - 1) Melihat status Kesehatan pasien.
 - 2) Cuci tangan dengan 6 langkah.
 - 3) Siapkan peralatan (alat yang digunakan menonton film animasi)
2. Tahap Orientasi
 - 1) Terapkan 3 S (senyum, salam, sapa).
 - 2) Menjelaskan kondisi pasien.
 - 3) Memberitahu tujuan dan pelaksanaan prosedur yang akan dilakukan pada pasien.
3. Tahap Kerja
 - 1) Beri kesempatan pasien dan orang tua pasien untuk bertanya saat

kurang jelas.

- 2) Menanyakan Kembali keluhan pada pasien.
- 3) Menjaga privasi pasien.
- 4) Posisikan pasien dengan nyaman.
- 5) Memberikan Teknik distraksi visual dengan durasi 5-10 menit berupa video animasi.
- 6) Menganjurkan orang tua untuk melaksanakan Teknik distraksi visual saat anak mengalami cemas.

2.5 Konsep Bermain Mewarnai

2.5.1 Pengertian Bermain Mewarnai

Terapi bermain mewarnai merupakan salah satu kegiatan yang sesuai dengan prinsip rumah sakit dimana secara psikologis, kegiatan ini dapat membantu anak dalam mengekspresikan perasaan cemas, takut, sedih, tertekan dan emosi (Wardani dkk., 2023). Terapi bermain mewarnai merupakan salah satu permainan yang memberikan kesempatan anak untuk bebas berekspresi dan sangat terapeutik (sebagai permainan penyembuh) (Sudirman dkk., 2023).

2.5.2 Tujuan Bermain Mewarnai

Tujuan bermain mewarnai menurut Machillah & Basuki, (2021) antara lain:

1. Gerakan motorik halusnya lebih terarah.
2. Dapat bermain sesuai tumbuh kembangnya.
3. Berkembang kognitifnya.
4. Dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sebaya.

5. Cemas selama dirawat di rumah sakit berkurang.

2.5.3 Manfaat Bermain Mewarnai

Manfaat bermain mewarnai menurut Siahaan (2022) antara lain:

1. Mewarnai meningkatkan konsentrasi.
2. Mewarnai gambar merupakan media berekspresi.
3. Mewarnai merupakan media terapi.
4. Membantu mengenal perbedaan warna.
5. Mewarnai melatih kemampuan koordinasi.
6. Dapat membantu menggenggam pensil.
7. Mewarnai membantu kemampuan motorik.

2.5.4 Langkah-Langkah Bermain Mewarnai

Langkah-langkah distraksi visual menurut Wardani dkk (2023) antara lain:

1. Tahap Pra Interaksi
 - 1) Melihat status kesehatan pasien.
 - 2) Cuci tangan dengan 6 langkah.
 - 3) Siapkan peralatan untuk terapi bermain mewarnai.
 - 4) Berikan tempat yang nyaman.
2. Tahap Orientasi
 - 1) Terapkan 3 S (senyum, salam, sapa).
 - 2) Menjelaskan kondisi pasien.
 - 3) Memberitahu tujuan dan pelaksanaan prosedur yang akan dilakukan pada pasien.
3. Tahap Kerja

- 1) Beri kesempatan pasien dan orang tua pasien untuk bertanya saat kurang jelas.
- 2) Pasien diminta untuk memilih gambar yang ingin diwarnai yang sudah tersedia.
- 3) Kemudian pasien dianjurkan mewarnai gambar yang disukai dengan durasi waktu 20 menit.

2.6 Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo

Hospitalisasi adalah suatu proses yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani terapi dan perawatan yang sampai pemulangan kembali ke rumah (Sudirman dkk., 2023). Kecemasan yang dialami anak usia prasekolah saat rawat inap di rumah sakit karena perpisahan dengan orang tua, lingkungan rumah sakit yang asing, dan prosedur medis yang menimbulkan rasa takut. Secara fisiologis, kecemasan dipicu oleh aktivasi sistem saraf otonom yang menstimulasi *hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis*, sehingga meningkatkan sekresi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang memengaruhi detak jantung, pola napas, dan ketegangan otot (Hidayah dkk., 2025).

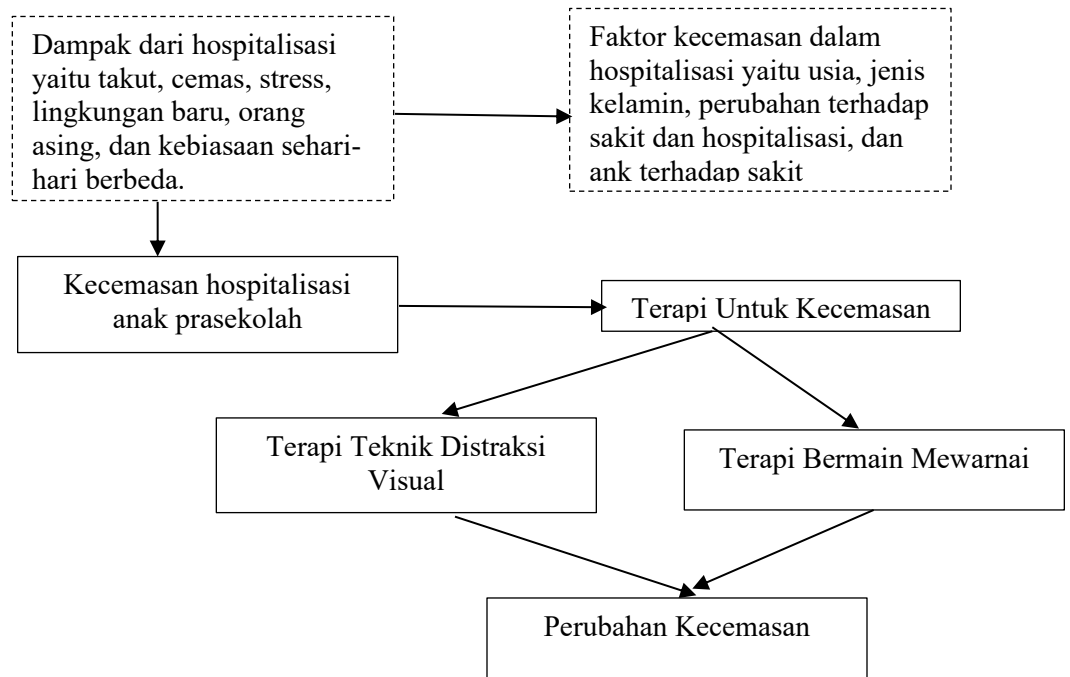
Kecemasan yang dialami oleh anak prasekolah dapat dialihkan dengan pemberian teknik distraksi visual dan bermain mewarnai. Terapi teknik distraksi visual bermanfaat untuk mengurangi kecemasan pada anak prasekolah (Lestari & Suminar, 2024). Terapi bermain mewarnai bermanfaat untuk mengurangi stres dan kecemasan juga untuk meningkatkan komunikasi pada anak serta bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak (Wardani

dkk., 2023).

BAB III METODE PENELITIAN

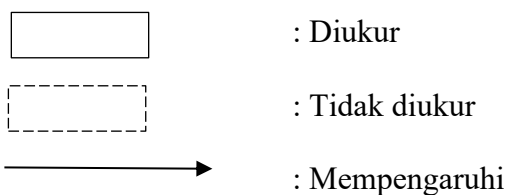
3.1 Kerangka Konsep

Uraian kerangka yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terdapat di dalam asumsi teoris (Nining, 2016).



3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo

Keterangan:



Dari gambar diatas dijelaskan bahwa hospitalisasi pada anak prasekolah memiliki dampak takut, stress, cemas, lingkungan yang baru dan orang yang asing yang dapat menyebabkan kecemasan pada anak saat di rumah sakit. Kecemasan mempengaruhi beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin,

pengalaman terhadap sakit dan perawatan hospitalisasi, persepsi anak terhadap sakit. Dampak hospitalisasi dapat diberikan terapi teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai dengan harapan tingkat kecemasan dapat berkurang.

3.2 Kerangka Konsep

- H1 : ada pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo
- H0 : tidak ada pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, desain penelitian yang digunakan penelitian ini adalah analitik tipe *Quasi eksperimen* dengan menggunakan pendekatan *two group pre-post test design*. *Quasi eksperimen* adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan dua kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah intervensi (Nursalam, 2020). Penelitian ini menganalisis pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.

Tabel 4.1 *Two group Pre-Post Test Design*

Kelompok	Pre	Perlakuan	Post
Teknik distraksi visual	A1	I1	A2
Terapi Bermain Mewarnai	B1	I2	B2

Keterangan:

A1: Kecemasan sebelum dilakukan teknik distraksi visual.

A2: Kecemasan sesudah dilakukan teknik distraksi visual.

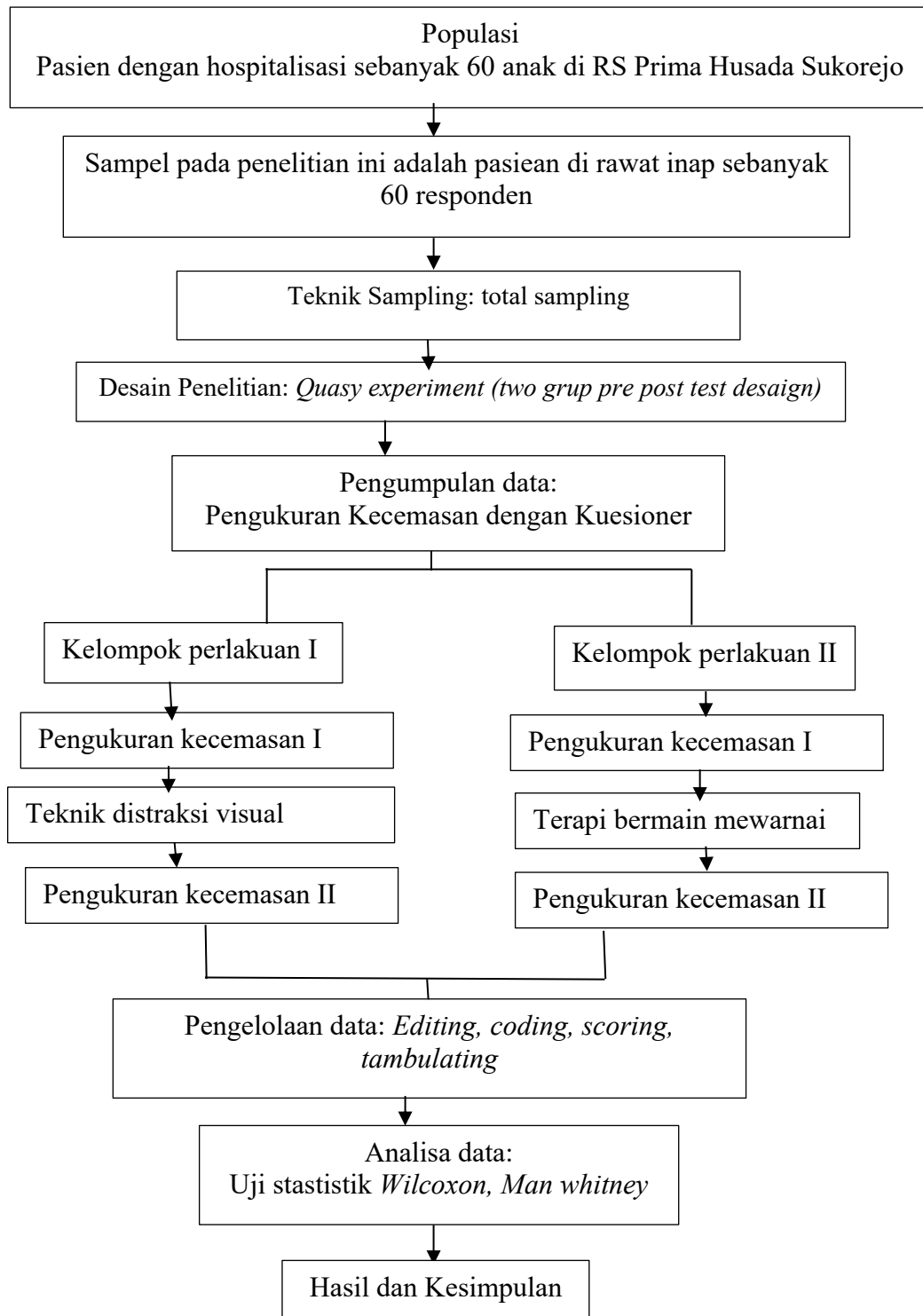
B1: Kecemasan sebelum dilakukan terapi bermain mewarnai.

B2: Kecemasan sesudah dilakukan terapi bermain mewarnai.

I1: Perlakuan terapi teknik distraksi visual.

I2: Perlakuan terapi bermain mewarnai.

4.2 Kerangka Kerja



4.1 Kerangka Kerja Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

4.3.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah pasien anak yang dirawat inap terdata di RS Primas Husada Sukorejo sebanyak 60 pasien.

4.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan adalah pasien anak yang dirawat inap terdata di RS Primas Husada Sukorejo sebanyak 60 responden.

4.3.3 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel memakai jumlah populasi (Sugiyono, 2020).

4.4 Kriteria Sampel

4.4.1 Kriterion Inklusi

Kriteria inklusi pada penelitian ini antar lain:

1. Pasien anak usia prasekolah.
2. Kooperatif saat penelitian.
3. Orang tua mengizinkan anak untuk diberi terapi.

4.4.2 Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi dan indikator penelitian ini antara lain:

1. Responden yang tidak kooperatif.
2. Keadaan responden tidak stabil.
3. Kecemasan berat.

4.5 Variabel Penelitian

4.5.1 Variabel Indenpenden

Variabel indenpenden pada penelitian ini adalah teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai.

4.5.2 Variabel Dependen

Variabel denpenden pada penelitian ini adalah kecemasan.

4.6 Definisi Operasional

Tabel 4.6 Definisi Operasional					
Variabel	Definisi Operasional	Prameter	Instrumen	Skala	Skor
Variabel indenpenden: teknik distraksi visual	Metode mendengarkan kartun untuk usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi	Anak mampu dan fokus mendengarkan cerita kartun yang diputar	SOP teknik distraksi visual	-	-
Variabel indenpenden: terapi bermain mewarnai	Metode bermain mewarnai gambar untuk anak prasekolah yang mengalami hospitalisasi	Anak mampu menyelesaikan terapi bermain mewarnai dengan alat yang disediakan	SOP terapi bermain mewarnai	-	-
Variabel dependen: kecemasan	Ketakutan yang dialami anak usia prasekolah saat hospitalisasi	Takut, gelisah, sedih, sulit konsentrasi	Kuesioner anak <i>Preschool Anxiety Scale</i>	Ordianal	Skor < 29: gejala ringan Skor 28-56: gejala sedang Skor 57-84: gejala berat Skor > 85: Panik

4.7 Tempat dan Waktu Penelitian

4.7.1 Tempat Peneltian

Penelitian ini dilakukan di rumah sakit Prima Husada Sukorejo.

4.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dengan pembuatan proposal pada bulan Juni 2025. Dilanjutkan dengan pengambilan data penelitian dibulan Oktober 2025.

4.8 Pengumpulan Data

4.8.1 Proses Pengumpulan Data

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perizinan

- 1) Peneliti mengajukan judul terlebih dahulu pada institusi pendidikan STIKes Kendedes.
- 2) Peneliti meminta surat pengajuan permohonan izin penelitian dan studi pendahuluan di institusi pendidikan STIKes Kendedes.
- 3) Setelah mendapat surat izin dari institusi pendidikan peneliti membawa surat tembusan dari institusi ditujukan kepada Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- 4) Setelah mendapat surat izin dari kepada Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo kemudian membawa surat tembusan ke kepala ruangan rawat inap rumah sakit Prima Husada Sukorejo bahwa akan melakukan penelitian di ruangan rawat inap.
- 5) Penelitian membuat proposal dengan bimbingan dari institusi pendidikan. Setelah itu proposal diajukan terlebih dahulu kemudian dilakukan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pada bulan Oktober peneliti mensurve data responden yang ada di rawat inap RS Prima Husada Sukorejo.
- 2) Setelah itu peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada responden dan keluarga responden.

- 3) Orang tua responden bersedia diminta untuk menandatangani lembar persetujuan responden dan peneliti melakukan kontrak waktu untuk pre-test dan intervensi pada pagi hari jam 07.00-09.30 WIB.
- 4) Penelitian ini dilakukan selama 3 hari. Penelitian ini dibantu dengan teman sebanyak 5 orang. Peneliti melakukan penelitian pada pasien yang diberikan terapi teknik distraksi visual sebanyak 10 pasien. Teman A dan B memberikan terapi yang sama masing-masing 10 pasien. Teman C, D, dan E melakukan pasien yang diberikan terapi bermain mewarnai masing-masing 10 pasien.
- 5) Sebelum diberikan terapi orang tua pasien disarankan mengisi kuesiner kecemasan pasien dan isi data pasien.
- 6) Setelah itu pasien kelompok perlakuan teknik distraksi visual diberikan terapi 1x sehari dengan durasi 5-10 menit. Untuk pasien kelompok terapi bermain mewarnai diberikan terapi 1x sehari dengan durasi 20 menit.
- 7) Setelah itu diobservasi setelah pemberian terapi.

4.8.2 Alat Pengukuran Data

Penelitian ini untuk mengambil data menggunakan wawancara, lembar kuesioner, dan lembar observasi. Data demografi mencakup nama, jenis kelamin, dan penyakit. Alat pengukuran yang digunakan mengukur kecemasan menggunakan kuesioner kecemasan anak. Kuesioner ini akan diisi oleh keluarga pasien dan terdiri dari 28 pertanyaan dengan criteria jawaban. Nilai 0 tidak benar sama sekali, nilai

1 jarang benar, nilai 2 kadang-kadang benar, nilai 3 cukup sering benar, dan nilai 4 sangat sering benar.

4.8.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah salah satu instrumen yang valid berupa alat ukur yang digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Nursalam, 2020). Pada penelitian ini tidak dilakukan uji validitas pada lama hari dan kuesioner kecemasan *The Pediatric Anxiety Rating Scale* (PARS) Preschool Parent Report karena sudah digunakan dalam penelitian internasional dengan hasil valid. Penelitian Maharjan (2019) dalam *penelitian Psychometric Properties of Nepali Translated Version of Preschool Anxiety Scale (Parent) Among Preschool Children in Nepal* diperoleh nilai validitas rhitung = 0,87.

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat dapat dipercaya atau diandalkan (Nursalam, 2020). Uji reliabilitas digunakan untuk mencari layak tidaknya kuesioner dipakai untuk instrument penelitian. Hasil dari uji reliabilitas penelitian Maharjan (2019) *Psychometric Properties of Nepali Translated Version of Preschool Anxiety Scale (Parent) Among Preschool Children in Nepal* diperoleh nilai cronbach alfa = 0,76. Nilai cronbach alfa $0,76 > 0,7$.

4.9 Pengolahan Data

4.9.1 Editing

Peneliti memeriksa kelengkapan kuesioner yang telah diberikan kepada responden, meliputi identitas responden dan pertanyaan yang diisi responden. Peneliti juga memastikan bahwa kuesioner diisi sesuai dengan petunjuk.

4.9.2 Coding

Peneliti memberikan kode setiap kriteria yang dipergunakan, maka peneliti dipermudahkan untuk menganalisis.

1. Data Umum

1) Jenis Kelamin

Perempuan : 1

Laki-laki : 2

2) Penyakit

Tidak parah : 1

Parah : 2

2. Data Khusus

Kecemasan

< 28 = gejala ringan : 1

29-56 = gejala sedang : 2

57-84 = gejala berat : 3

> 85 = panik : 4

4.9.3 Scoring

Tahap scoring dalam penelitian ini adalah proses pemberian skor atau nilai numerik terhadap data yang telah dikodekan (Nursalam, 2020).

< 28 = gejala ringan : 1

29-56 = gejala sedang : 2

57-84 = gejala berat : 3

> 85 = panik : 4

4.9.4 Tabulating

Dari data mentah dilakukan pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan di analisis.

4.10 Analisa Data

4.10.1 Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan setiap variabel penelitian secara tunggal (satu per satu), tanpa melihat hubungan dengan variabel lain. Analisis ini biasanya bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi, persentase, rata-rata (*mean*), standar deviasi, median, nilai minimum dan maksimum dari suatu variabel (Nursalam, 2020).

4.10.2 Analisis Bivariat

Analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan. Analisis bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknik distraksi visual dan terapi bermain mewarnai terhadap kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo. Akan dilakukan uji normalitas data menggunakan *shapiro wilk*. Apabila data berdistribusi normal Uji *Dependent T-Test* dan *Independen T-Test*. Apabila data berdistribusi tidak normal memakai *Uji Wilcoxon* dan *Uji Mann Whitney*.

4.11 Etik Penelitian

Etika penelitian adalah seperangkat prinsip moral yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, terutama yang

melibatkan manusia sebagai responden. Etika ini bertujuan untuk melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan responden, serta menjaga integritas penelitian (Nursalam, 2020). Konsep-konsep nilai etik penelitian antara lain:

4.11.1 Informed Consent

Informed consent adalah bentuk persetujuan yang diberikan peneliti ke responden. Informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan dari Informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya.

4.11.2 Anonymity

Anonymity atau tanpa nama adalah suatu jaminan untuk penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

4.11.3 Confidentiality

Confidentiality (kerahasiaan) merupakan jaminan untuk memberikan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

4.11.4 Beneficence

Prinsip ini menuntut peneliti untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat, baik yang menguntungkan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

4.11.5 *Justice*

Penelitian ini peneliti harus bersikap adil kepada responden, dan responden akan mendapat penjelasan.

4.11.6 *Non maleficence*

Kewajiban untuk tidak membahayakan responden penelitian. Responden berhak memutuskan dengan sukarela dengan apakah ikut ambil bagian dalam penelitiann tanpa risiko yang merugikan pada penelitian ini.

4.11.7 *Inducements*

Penelitian harus dihindari dari kecurigaan atas klaim adanya “eksploitatif” terhadap subjek yang berkaitan dengan aspek manfaat dan bahaya (*benefit and harm*) kerentanan (*vulnerability*) dan persetujuan (*consent*).

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., Sari, R. S., & Diel, M. M. (2024). PENGARUH TERAPI BERMAIN MEWARNAI TERHADAP KECEMASAN ANAK DI RS AN-NISA. *Jurnal Ilmu Kesehatan Media Nutrica*, 7 (1).
- Hidayah, A., Rahmawati, A., & Sutandi, A. (2025). Pengaruh Bercerita Dengan Media Boneka Jari Terhadap Tingkat Kecemasan Anak Usia Prasekolah Selama Hospitalisasi Di RSUD Koja. *Journal of Nursing and Midwifery Sciences*, 4(1).
- Khalimi, A. (2023). *PENGARUH COLORING PLAY TERAPI TERHADAP KECEMASAN PASIEN RAWAT INAP USIA PRASEKOLAH DI RUANG MINA RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN*.
- Kurnisar, Waluyati, S. A., & Fatihah, H. (2024). *Perkembangan Peserta Didik. Bening Media Publishing*.
<https://books.google.co.id/books?id=yiseEQAAQBAJ>
- Leni, P. (2020). *EFEKTIFITAS PEMBERIAN TERAPI BERMAIN PUZZLE DAN TERAPI BERMAIN MENGGAMBAR TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA ANAK USIA PRASEKOLAH (3-6 TAHUN) DALAM MENGHADAPI HOSPITALISASI DI RSU DARMAJU PONOROGO*.
- Lestari, D. H., & Suminar, E. (2024). Efektivitas Teknik Distraksi Audiovisual Terhadap Derajat Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Prasekolah. *Indonesian Journal of Professional Nursing*, 5(1), 33–40.
- Machillah, L. N., & Duwi Basuki, M. (2021). *Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai Gambar Terhadap Tingkat Kecemasan Anak Usia Prasekolah Akibat Hospitalisasi Di Ruang Asoka Rsud Bangil Kabupaten Pasuruan*.
- Maulidia, N. L., Ratnaningsih, T., & Peni, T. (2023). *Pengaruh Teknik Distraksi Visual (Video Cartoon) Terhadap Tingkat Nyeri Pemasangan Infus Pada Anak Usia Todler di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo*.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi ke-5*. Salemba Medika.
- Purnama, R., Anggraini, S., Ismanto, R. A., & Trisna, D. (2024). *Implementasi Terapi Non Farmakologi dengan Masalah Post Operasi Appendektomi*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=Z6MUEQAAQBAJ>
- Siahaan, E. R. (2022). PENGARUH TERAPI BERMAIN MEWARNAI TERHADAP KECEMASAN PADA ANAK USIA PRASEKOLAH AKIBAT HOSPITALISASI. *Jurnal Keperawatan Bunda Delima*, 4(2), 14–19.
- Sudirman, A. A., Modjo, D., & Azis, R. A. (2023). Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Tingkat Kecemasan Efek Hospitalisasi Pada Usia Pra

Sekolah Di Ruang Perawatan Anak RSUD Tani Dan Nelayan Boalemo.
Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi, 1(2), 100–112.

Triana, N. A. (2025). *PENERAPAN TERAPI DISTRAKSI AUDIOVISUAL TERHADAP MASALAH KEPERAWATAN ANSIETAS AKIBAT HOSPITALISASI PADA ANAK USIA PRASEKOLAH DENGAN LEUKEMIA*.

Wardani, R. N., Agustina, M., & Safitri, A. (2023). Pengaruh terapi mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan pada anak prasekolah selama hospitalisasi di Ruang Jasmine RS Yadika Kebayoran Jakarta Selatan Tahun 2022. *The Journal General Health and Pharmaceutical Sciences Research*, 1(1), 01–18.

Yan, L. S. (2023). *PENERAPAN TERAPI BERMAIN UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECEMASAN PADA ANAK USIA PRASEKOLAH*. Nuansa Fajar Cemerlang. <https://books.google.co.id/books?id=P9mDEQAAQBAJ>

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :

Yth. Calon Responden Penelitian
di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intania Cahya Andini

NIM : 2401160877

Pekerjaan : Mahasiswa semester II Program Studi Sarjana Keperawatan

Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.6, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada saudara untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo”. Pengumpulan datanya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo. Saya akan tetap menjaga segala kerahasiaan data maupun informasi yang diberikan.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian, kerjasamanya dan kesediaannya saya mengucapkan terima kasih.

Pasuruan,2025

Peneliti

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Setelah membaca Lembar Permohonan Menjadi responden yang diajukan oleh saudari, Intania Cahya Andini, Mahasiswa semester II Program Studi Sarjana Keperawatan STIKES KENDEDES, yang penelitiannya berjudul “Pengaruh Teknik Distraksi Visual Dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Di RS Prima Husada Sukorejo.”, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian tersebut, secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Demikian surat persetujuan ini saya berikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,.....2025

Responden

(.....)

Lampiran 3

Lembar Profil Responden

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Hari perawatan :

Pengalaman masuk rumah sakit :

Lampiran 4

KEESIONER PRESCHOLL ANXIETY SCALE

Tidak sama sekali = 0

Jarang = 1

Kadang-kadang = 2

Cukup sering = 3

Sangat sering = 4

Petunjuk: berikan tanda (✓) pada setiap kolom jawaban yang tersedia dibawah ini dengan kondisi dan situasi yang anak anda alami berkaitan dengan selama dirumah sakit.

No	Pertanyaan	Tidak sama sekali (0)	Jarang (1)	Kadang- kadang (2)	Cukup sering (3)	Sangat sering (4)
1	Anak saya selalu khawatir bila diajak kerumah sakit					
2	Anak aya merasa cemas/takut bila berhadapan dengan orang lain (perawat,dokter)					
3	Saya melihat anak saya merasa takut jika lampu kamar dimatikan					
4	Selama dirumah sakit anak saya mudah merasa cemas/takut hal ini terlihat dari sikapnya yang gelisah dan mudah marah					
5	Anak saya terlihat takut untuk berbicara/meminta bantuan kepada orang lain					
6	Anak saya sulit tidur/menangis bila saya(orang tua) tidak ada didekatnya					
7	Anak saya takut ketinggian (ruangan kamar dilantai atas)					
8	Anak saya sulit tidur karena khawatir/cemas					
9	Anak saya terlihat mencuci tangan berkali kali karena mrasa cemas dengan kuman dirumah sakit					
10	Anak saya takut akan tempat kermaian dan tertutup					
11	Anak saya takut bertemu dan berbicara dengan orang yang tidak dikenal					
12	Anak saya khawatir sesuatu					

- yang buruk akan terjadi pada orang tuanya
- 13 Anak saya takut pada perawat dan dokter
 - 14 Anak saya setiap hari mengkhawatirkan akan disuntik oleh perawat
 - 15 Anak saya takut berbicara dengan dokter pada saat dokter sedang visite (keliling untuk memeriksa)
 - 16 Anak saya takut khawatir sesuatu yang buruk terjadi padanya(orangtua) sehingga dia menangis apabila ditinggal oleh ibu/bapaknya
 - 17 Anak saya takut dengan jarum
 - 18 Harus memiliki aktivitas/ permainan untuk mengalihkan perhatian pada rasa takut
 - 19 Anak saya khawatir akan melakukan sesuatu yang memalukan di depan orang lain (memukul dokter/perawat
 - 20 Anak saya takut pada serangga dan laba-laba
 - 21 Anak saya memiliki pikiran buruk yang terus muncul berulang kali
 - 22 Anak saya kesal/menangis jika ditinggalkan sendirian dengan pengasuh saat di rumah sakit
 - 23 Anak saya takut untuk pergi ketaman bermain rumah sakit sendiri dan bergabung dengan orang lain
 - 24 Anak saya takut dengan tindakan keperawatan
 - 25 Anak saya sering mimpi buruk (ngelindu/mengigau) saat tidur dengan memanggil orang tua
 - 26 Anak saya takut dengan kegelapan
 - 27 Anak saya harus bermain untuk melupakan hal-hal buruk (tindakan keperawatan)
 - 28 Anak saya meminta izin untuk bermain meskipun itu tidak perlu

Lampiran 5

Lembar Observasi Teknik Distraksi Visual

NO	Responden	Pre Test	Post Test
-----------	------------------	-----------------	------------------

Lampiran 6

Lembar Observasi Terapi Bermain Mewarnai

NO	Responden	Pre Test	Post Test
-----------	------------------	-----------------	------------------

Lampiran 7

STANDART OPERASINONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIK DISTRAKSI (VISUAL

NO	SOP	TEKNIK DISTRAKSI VISUAL
1.	PENGERTIAN	Distraksi visual adalah suatu cara untuk mengalihkan fokus anak terhadap rasa sakit melalui instrumen visual yang menyenangkan bagi anak
2.	TUJUAN	Pengelihan perhatian klien terhadap sesuatu yang akan di hadapi
3.	MANFAAT	Klien merasa lebih rileks, santai dan merasa pada situasi yang aman, nyaman dan menyenangkan
		TAHAP PELAKSANAAN
4.	TAHAP PRA INTERAKSI	1) Melihat status Kesehatan pasien. 2) Cuci tangan dengan 6 langkah. 3) Siapkan peralatan (alat yang digunakan menonton film animasi)
5.	TAHAP ORIENTASI	1) Terapkan 3 S (senyum, salam, sapa). 2) Menjelaskan kondisi pasien. 3) Memberitahu tujuan dan pelaksanaan prosedur yang akan dilakukan pada pasien.
6.	TAHAP KERJA	1) Beri kesempatan pasien dan orang tua pasien untuk bertanya saat kurang jelas. 2) Menanyakan Kembali keluhan pada pasien. 3) Menjaga privasi pasien. 4) Posisikan pasien dengan nyaman. 5) Memberikan Teknik distraksi visual dengan durasi 5-10 menit berupa video animasi. 6) Menganjurkan orang tua untuk melaksanakan teknik distraksi visual saat anak mengalami cemas.
7.	TAHAP TERMINASI	1. Menghentikan video setelah prosedur selesai. 2. Memberikan penguatan positif kepada anak. 3. Menyampaikan terima kasih kepada anak dan orang tua. 4. Menjelaskan bahwa prosedur telah selesai dan anak berperilaku hebat.

Maulidia, N. L. (2023). Pengaruh Teknik Distraksi Visual (video cartoon) terhadap tingkat nyeri pemasangan infus pada anak usia toddler.

STANDART OPERASINONAL PROSEDUR (SOP) TERAPI BERMAIN MEWARNAI

NO		SOP TERAPI BERMAIN MEWARNAI
1.	PENGERTIAN	Terapi bermain mewarnai merupakan salah satu kegiatan yang sesuai dengan prinsip rumah sakit dimana secara psikologis, kegiatan ini dapat membantu anak dalam mengekspresikan perasaan cemas, takut, sedih, tertekan dan emosi
2.	TUJUAN	Mengurangi kecemasan saat dirawat di rumah sakit.
3.	MANFAAT	Mengurangi kecemasan pada anak usia prasekolah
		TAHAP PELAKSANAAN
4.	TAHAP PRA INTERAKSI	1) Melihat status kesehatan pasien. 2) Cuci tangan dengan 6 langkah. 3) Siapkan peralatan untuk terapi bermain mewarnai. 4) Berikan tempat yang nyaman.
5.	TAHAP ORIENTASI	1) Terapkan 3 S (senyum, salam, sapa). 2) Menjelaskan kondisi pasien. 3) Memberitahu tujuan dan pelaksanaan prosedur yang akan dilakukan pada pasien.
6.	TAHAP KERJA	1) Beri kesempatan pasien dan orang tua pasien untuk bertanya saat kurang jelas. 2) Pasien diminta untuk memilih gambar yang ingin diwarnai yang sudah tersedia. 3) Kemudian pasien dianjurkan mewarnai gambar yang disukai dengan durasi waktu 20 menit.
7.	TAHAP TERMINASI	1. Mendokumentasikan hasil terapi yang diberikan. 2. Izin kontrak waktu untuk pemberian terapi. 3. Menyampaikan terimakasih.

Wardani, R. N., Agustina, M., & Safitri, A. (2023). Pengaruh terapi mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan pada anak prasekolah selama hospitalisasi di Ruang Jasmine RS Yadika Kebayoran Jakarta Selatan Tahun 2022

Lampian 6

**FORM KEWAJIBAN KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI
(S1-KEPERAWATAN)**

PEMBIMBING 1 (PROPOSAL + SKRIPSI)

Data Pembimbing 1

Nama Pembimbing 1 Ns.Luluk Nur Aini,M.Kep
NIDN

Data Mahasiswa Bimbingan

Nama Lengkap Intania Cahya Andini
NIM 2401160877
Kelas Procyon
Tema/Topik Penelitian Anak
Judul Skripsi Pengaruh Teknik Distraksi Visual dan Kompres Dingin Terhadap Tingkat Nyeri Pemasangan Infus Pada Anak Usia Prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.

No	TGL Konsultasi	JAM	MATERI PEMBAHASAN	TTD PEMBIMBING
1.	1 -06-2025	09.31	Konsul judul : lanjutkan bab 1-2	
2.	04-06-2025	07.41	Konsul bab 1-2 : “tambahi komplementarnya dijudul cari yg relevan” Konsul judul pengaruh Teknik distraksi visual (video cartoon) dan kompres dingin terhadap tingkat nyeri pemasangan infus pada anak usia prasekolah: “silahkan”	
3.	11-06-2025	14.22	Konsul Bab 1-2 : “ lanjut kek bab selanjutnya sampai lampiran dan buat lembar konsultasi”	
4.	21-07-2025		Konsul bab 1-4 : Revisi 1. Judul piramida,dimana tempat penelitisnya 2. Sesuaikan buku panduan cara penulisan nama ada dimana 3.Bab 1 perbaiki penulisannya 4.Bab 2 Apa hubungannya Konsep Dasar injeksi/intravena -Perhatikan cara penulisan table garis vertical dihapus , font 10 spasi 1 6.Bab 3 Kerangka konsep dijelaskan mana input proses dan outputnya ,narasikan kerangka konsep ini secara deskriptif -Penulisan gambar 3.1 font 9 -Perbaiki Hipotesisnya 7.Bab 4 Bagaimana penerapan dalam penelitian ini ? -Berapa frekuensi suaranya ? alatnya pakai apa ? - Revisi Analisis bivariate	
5.	24-07-2025		Konsul yang sudah direvisi bab 1-4	
6.	28-07-2025		Revisi “Uji bivariatnya silahkan ganti parametis”	
7.	28-07-2025		ACC ujian sempro	

FORM KEWAJIBAN KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI

(S1-KEPERAWATAN)

PEMBIMBING 2 (PROPOSAL + SKRIPSI)

Data Pembimbing 2

Nama Pembimbing 2 Desy Rinawaty,M.Tr.Kep
NIDN

Data Mahasiswa Bimbingan

Nama Lengkap Intania Cahya Andini
NIM 2401160877
Kelas Procyon
Tema/Topik Penelitian Anak
Judul Skripsi Pengaruh Teknik Distraksi Visual dan Kompres Dingin Terhadap Tingkat Nyeri Pemasangan Infus Pada Anak Usia Prasekolah di RS Prima Husada Sukorejo.

No	TGL Konsultasi	JAM	MATERI PEMBAHASAN	TTD PEMBIMBING
1.	1 -06-2025	09.31	Konsul judul : lanjut	
2.	04-06-2025	07.41	Konsul judul yg sudah direvisi : Pengaruh Teknik distraksi visual (video cartoon) dan kompres dingin terhadap tingkat nyeri pemasangan infus pada anak usia prasekolah: “lanjut ”	
4.	21-07-2025	07.54 09.22	Konsul bab 1-4 : Revisi 1.Bab 1 latar belakang : Bisa dijelaskan lebih spesifik mengapa distraksi dikombinasi dg kompres 2.Bab 3 : Ditambahkan Hipotesisnya 3.Bab 4 : Jika menggunakan 2 kelompok control dan intervensi maka untuk rancannya bisa di sesuaikan lagi	
5.	24-07-2025	09.29	Konsul yang sudah direvisi bab 1-4	
6.	26-07-2025	09.41	Revisi Bab 1-4 1. Bab 1 : Rumusan masalah “Apakah diganti bagaimana” 2.Bab 4 : Analisis Bivariat “Dijelaskan jika data berdistribusi normal menggunakan Uji apa jika data tidak normal menggunakan Uji apa “ 3.Daftar Pustaka “ Referensi bab 1-3 silahkan dimasukkan” 4.Lampiran “Ditambahkan SOP”	
7.	28-07-2025	08.17	ACC ujian sempro	